

保险 II 行业

从医疗保险体系看我国健康险市场的空间

核心观点:

- 本篇报告通过对比海外成熟国家的医疗保险体制和卫生费用结构,参考我国人口结构、卫生费用结构,从需求侧的角度论述及测算我国健康险行业的中长期发展空间。
- 医疗保险制度主要分为四大模式: (1) 国家卫生服务制度: 以英国为代表。国家卫生服务体系 (NHS) 覆盖全体国民,由初级医疗服务 (全科医师) 和医院服务构成,免费享受综合医疗服务,仅牙科和处方药需共同负担,因此财政占卫生费用的比重超过 80%; (2) 市场医疗保险制度: 美国为代表,主要以商业医疗保险和社会医疗保险 (Medicare、Medicaid) 组成,分别覆盖 34.8%、66.5% 的人口。美国卫生费用筹资来源商业医疗保险 (31%)、社会医疗保险 (42%)、个人现金 (11%)。 (3) 社会医疗保险制度,以德法日为代表。德国强制要求收入低于标准的人必须参加法定医疗保险 (费率 14.6%),覆盖 88.2% 的人群,而高于标准的人可自由选择。法定医疗保险保障范围涵盖疾病预防、疾病医疗费用、病假津贴、生育费用和心理治疗等。 (4) 个人储蓄医疗保险制度: 以新加坡为代表,以保健储蓄计划、个人终身医疗保险 (终身健保和私人医疗保险) 等构成,公积金制度要求居民按照收入的 37% (55 岁以下) 缴纳费用,其中 8%-10% 计入保健账户,支付相关费用,因保健账户使用范围受限,49.8% 的人购买私人医疗保险。
- 我们通过分析典型医疗保险制度的典型国家卫生费用筹资结构发现一个共性特点: 无论何种医疗保险制度,成熟的过程都是在人口结构变化导致医疗费用上涨的背景下降低居民自费比例,以能够获得更好的医疗健康服务。据 OECD 数据显示,2018 年英国/美国/德国/法国/日本卫生费用中自费比例分别为 16.7%/10.8%/12.7%/9.3%/12.8%。反观我国,虽然 2019 年基本医疗保险覆盖 96.7% 的人口,但卫生费用结构中自费比例高达 28.4%。
- 我们不同于过往通过寿险密度和深度的方式来量化测算商业健康险的发展空间,而是从居民的需求端来测算,一是筹资水平 (卫生费用/GDP 比重) 低于 OECD 平均水平,且人均 GDP 也较低,有提升的空间;二是筹资结构中公共资金占比相对较高但仍低于发达国家,且自费比例明显较高。未来降低自费比例无非是两条路,提高公共资金或者商业健康险占比,根据对 GDP、卫生费用占 GDP 比重、公共资金占比、健康险赔付率等的审慎假设, 测算出未来 10 年健康险保费有望实现年均复合增速 10%-14%,达到 2.1 万亿-3 万亿左右的水平。
- 投资建议: 中长期推荐: 中国平安 (A/H)、友邦保险 (H)、中国太保 (A/H)。
- 风险提示: 利率下行超预期,新单销售不达预期。

行业评级

买入

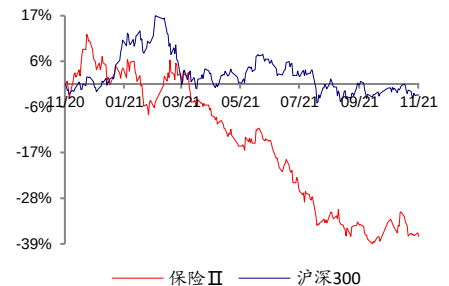
前次评级

买入

报告日期

2021-11-11

相对市场表现



分析师:

刘洪



SAC 执证号: S0260520060001



0755-82564292



liuqi@gf.com.cn

分析师:

陈福



SAC 执证号: S0260517050001



SFC CE No. BOB667



0755-82535901

chenfu@gf.com.cn

请注意, 刘洪并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

保险 II 行业: 三季报综述: 寿险 2021-11-02

符合预期, 财险略超预期

保险 II 行业: 长端利率上行, 资产端改善利好估值修复 2021-10-20

待拐点, 财险曙光将现

保险 II 行业: 中报综述: 寿险仍 2021-09-01

待拐点, 财险曙光将现

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		PEV(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
中国平安	601318.SH	CNY	49.13	20211028	买入	79.7	6.28	9.36	7.82	5.25	0.62	0.54	12.81%	17.37%
新华保险	601336.SH	CNY	37.94	20211031	买入	61.8	5.87	7.40	6.46	5.13	0.43	0.38	14.87%	17.24%
中国太保	601601.SH	CNY	27.38	20210830	买入	43.51	2.83	3.74	9.67	7.32	0.50	0.43	12.75%	10.94%
中国人寿	601628.SH	CNY	28.55	20211031	买入	38.75	2.07	2.46	13.79	11.61	0.67	0.60	9.94%	9.62%
中国平安	02318.HK	HKD	56.70	20211028	买入	88.4	6.28	9.36	7.41	4.97	0.58	0.51	12.81%	17.37%
新华保险	01336.HK	HKD	21.80	20211031	买入	36.32	5.87	7.40	3.05	2.42	0.20	0.18	14.87%	17.24%
中国太保	02601.HK	HKD	23.95	20210830	买入	32.70	2.83	3.74	6.95	5.26	0.36	0.31	12.75%	10.94%
中国人寿	02628.HK	HKD	13.58	20211031	买入	17.71	2.07	2.46	5.38	4.53	0.26	0.23	9.94%	9.62%
友邦保险	01299.HK	HKD	82.55	20210818	买入	121.59	0.53	0.59	19.99	17.96	1.77	1.59	9.17%	9.46%
中国财险	02328.HK	HKD	6.86	20211029	买入	9.96	1.10	1.24	5.12	4.54	0.62	0.60	12.13%	13.18%

数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

备注: 表中估值指标按照最新收盘价计算, EPS 中仅友邦的货币为美元, 而其余均为人民币, 估值中仅中国财险是 PB, 其余均为 PEV

目录索引

一、成熟国家医疗体制和保险制度	6
（一）英国：国家卫生服务保障制度	6
（二）美国：商业医疗保险制度	8
（三）德法日：社会医疗保险制度	13
（四）新加坡：储蓄医疗保险制度	16
（五）成熟经济体的医保制度的共性：降低居民医疗支出成本	20
二、成熟国家人身险产品结构	21
（一）英国：养老金为主的人身险行业	21
（二）美国：以寿险为主的产品结构	22
（三）德国：寿险为主的人身险产品结构，	23
三、中外对比，我国医疗保障缺口较大，需求侧测算我国健康险未来有望实现 10%以上复合增速	25
（一）基本医疗保险覆盖广，但程度低，个人负担较重	25
（二）人口加速老龄化，医疗成本提升	26
（三）测算：健康险未来 10 年有望实现两位数的年均复合增速	27
四、投资建议	29
五、风险提示	30

图表索引

图 1: NHS 两层医疗体系	7
图 2: 英国医疗卫生费用支出	8
图 3: 英国医疗体系资金主要来源于公共资金	8
图 4: 美国医疗保险体系	9
图 5: 2020 年美国医疗保险覆盖 91.4% 人群	9
图 6: 美国健康保险未参保率走势	9
图 7: 美国公共和私人健康保险覆盖率	9
图 8: 2019 年 Medicare 医疗费用支出结构	10
图 9: 2019 年 Medicaid 医疗费用支出结构	10
图 10: 美国 65 岁以下私人医疗保险覆盖率	11
图 11: 美国劳动人口拥有的私人医疗保险比例	11
图 12: 私人医疗保险种类覆盖率	11
图 13: 美国人均卫生费用及同比增速	12
图 14: 美国卫生费用占 GDP 比重逐年提升	12
图 15: 2018 年成熟国家卫生费用支出占 GDP 比重 (%)	12
图 16: 2018 年成熟国家人均卫生费用支出 (美元)	12
图 17: 2019 年美国医疗费用来源	13
图 18: 2019 年美国医疗费用明细	13
图 19: 美国医疗费用来源结构	13
图 20: 德国法定医疗保险参保人数和参保率 (万人)	14
图 21: 德国法定医疗保险参保结构	14
图 22: 德国人均卫生费用及同比增速 (欧元)	15
图 23: 德国卫生费用占 GDP 比重逐年提升	15
图 24: 保健账户数 (百万)	18
图 25: 保健账户储蓄余额及占 GDP 比重 (十亿新元)	18
图 26: 私人医疗保险参保人数和渗透率	19
图 27: 新加坡卫生费用占 GDP 比重为 2.1%	20
图 28: 新加坡卫生费用来源结构	20
图 29: 2018 年成熟国家卫生费用中个人支出比重	21
图 30: 英国卫生费用支出中个人现金占比	21
图 31: 美国卫生费用支出中个人现金占比	21
图 32: 德国卫生费用支出中个人现金占比	21
图 33: 法国卫生费用支出中个人现金占比	21
图 34: 日本卫生费用支出中个人现金占比	21
图 35: 英国长期险保费收入及同比增速 (百万英镑)	22
图 36: 英国长期险以年金险为主	22
图 37: 英国 65 岁以上人口占比持续提升	22
图 38: 团体保障类产品参保人数	22
图 39: 美国人身险行业保费 (百万美元)	23

图 40: 美国人身险行业产品结构.....	23
图 41: 德国人身险保费规模 (百万欧元)	24
图 42: 德国人身险产品结构	24
图 43: 德国寿险行业产品结构	24
图 44: 德国人口老龄化趋势	24
图 45: 德国健康险产品结构	25
图 46: 我国卫生费用支出结构	26
图 47: 卫生费用和占 GDP 比重 (亿元)	27
图 48: 人均卫生费用陡峭式上升 (元)	27
图 49: 我国老龄化加速	27
图 50: 出生率首次降至历史 (‰)	27
图 51: 2019 年卫生费用占 GDP 比重的横向比较	28
图 52: 2020 年人均 GDP 水平 (美元)	28
图 53: 2018 年各国家卫生费用中公共筹资结构	28
图 54: 2018 年各国家卫生费用中自费比例	28

表 1: 主要医疗保险制度模式比较	6
表 2: 美国公共医疗保险制度	10
表 3: Medicare 医疗费用支出结构	10
表 4: 德国法定医疗保险制度	14
表 5: 德国卫生费用支出结构	15
表 5: 德国法定医疗保险参保人医疗费用自付明细	16
表 7: 德国卫生费用经常支出账户收入来源结构	16
表 8: 新加坡中央公积金缴费率	17
表 9: 保健账户使用的医疗费用和单项费用扣款上限	17
表 10: 终身健保计划赔付范围和限额	18
表 11: 终身健保计划的费率情况 (新元)	18
表 12: 友邦保险 HealthShield Gold Max 产品报销范围	19
表 13: 美国健康险特殊险种的规模和占比	23
表 14: 我国基本医疗保险制度	25
表 15: 2019 年社会医疗保险住院费用报销比例	26
表 16: 健康险空间测算 (亿元)	29

保险行业尤其是健康险行业在乘行业政策东风呈现爆发式增长后，随着人口红利和信息不对称的优势逐步消退，以及随着行业发展进入新常态、保险公司开启转型大幕，健康险增速尤其是上市保险公司健康险增速略微乏力，市场也对未来健康险的发展空间存在较大的疑虑。

本篇报告通过对比海外成熟国家的医疗保险体制和卫生费用结构，参考当前我国的人口结构、社会保障制度、卫生费用结构，从中长期的角度论述我国健康险的发展空间。

一、成熟国家医疗体制和保险制度

发达国家医疗保险制度和本国的政治、经济及文化有密切的关系，目前根据覆盖人群、政府责任和保障水平将成熟国家的医疗保险制度分为四大模式，包括以英国、加拿大、澳大利亚等为代表的国家卫生服务保障制度；以德国、法国、日本等为代表的法定医疗保险；以美国为代表的市场医疗保险制度；以新加坡为主的个人医疗储蓄制度。

表1：主要医疗保险制度模式比较

	国家卫生服务保障制度	商业医疗保险制度	社会医疗保险制度	个人储蓄医疗保险制度
保障对象	不以收入为条件，覆盖所有居民或部分特定群体	主要覆盖高收入群体	主要覆盖一般收入群体，也有国家把高收入和低收入都纳入	主要覆盖有收入人群
政府责任	政府主办	政府监管，社会主办	法律强制引导，社会主办	政府鼓励，个人自保
保障功能	包括医疗、预防保健，一般不包括疾病或生育津贴	包括住院保险、重大疾病保险	一般包括疾病医疗、生育津贴，逐步扩展至预防保健	一般包括住院医疗门诊特殊疾病
保障水平	保障基本健康需求，保障水平高	一般保障较高水平的医疗需求	保障基本的医疗需求	保障基本医疗需求
体系中地位	一般作为国家制度体系的主体	作为一个国家制度体系的补充	一般作为国家制度体系	可以作为一个国家制度体系的基础部分
典型国家	英国、加拿大、澳大利亚	美国	德国、法国	新加坡

数据来源：孙晓明《发达国家和地区医疗体制与保险制度》，广发证券发展研究中心

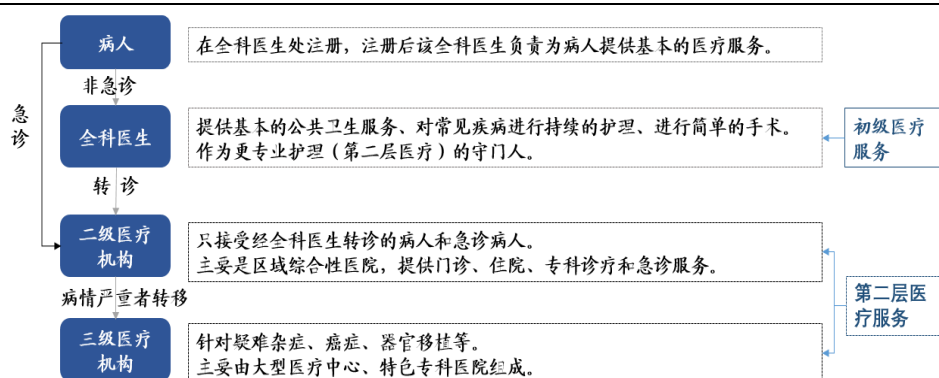
（一）英国：国家卫生服务保障制度

英国的医疗保障体系由英国国民卫生服务体系（简称NHS）、社会医疗救助、商业健康保险三部分共同构建。其中NHS是主体保障，基本覆盖全体国民，商业健康保险和医疗救助是其重要补充。1946年英国颁布《国家卫生服务法》，在西方首创了由政府税收统一支付的国家卫生服务体系，英国的医疗卫生制度的特点在于：一是国民健康卫生服务是通过国家计划安排的形式予以落实和保障；二是医疗卫生服务供给体系以公立医院为主；三是全民普遍免费享受的综合医疗卫生保健服务。英国国家卫生服务制度的宗旨在于英国居民不论性别年龄、文化程度和宗教信仰，都有权享受条件下最好的医疗服务。

1.从保障功能来看：免费享受医疗及预防保健服务

从保障功能来看，英国国家卫生服务保障制度主要保障包括医疗服务、预防保健服务，但一般不包括疾病津贴或生育津贴。医疗服务主要通过以“全科医师（GP）”提供社区医疗服务和以“医院”提供患者其他医疗等服务。英国居民首先每人指定与一名全科医师进行登记，先接受全科医师的诊疗，包括健康指导、是否需要去医院治疗必要性的判断，以及医疗卫生经费的使用和管理，而医院主要提供住院、生育、康复、医学保健服务，除了急救的情形外，原则上需要全科医生约定方可去国家卫生服务的医院接受诊疗。英国绝大部分的医疗由国家卫生服务提供，但也有一小部分的民营医疗机构存在，但民营机构的医疗费用全额由患者自担，除非是NHS向民营机构购买服务，减少NHS服务等候时间。

图1：NHS两层医疗体系



数据来源：NHS，广发证券发展研究中心

NHS覆盖所有英国合法居民（或计划在英国生活6个月以上的人群，如留学生等）。大部分服务在享受时都是免费，但在某些情况下，病人需要共同承担费用后完全自费（即NHS不覆盖该费用）。**共同承担费用的情况：**英国居民需要共同承担牙科治疗费用和处方药费用。英格兰的牙科治疗有三个收费范围：23.8英镑（临床检查等）、65.2英镑（拔牙、口腔手术、牙龈疾病治疗等）和282.8英镑（正畸治疗、假牙等）。另外，每种处方药需要自付9.35英镑，购买的处方药种类越多，自费金额越高，16岁以下、16-18岁的全日制学生及60岁以上人群可以免费获得处方药（数据来源：NHS）。**处方药费用豁免未成年人和老人**，英国居民实际处方药费用负担较小。**完全自费的情况：**基本的眼科服务和非处方药。非处方药由病人直接自费购买，不受NHS覆盖（资料来源NHS）。

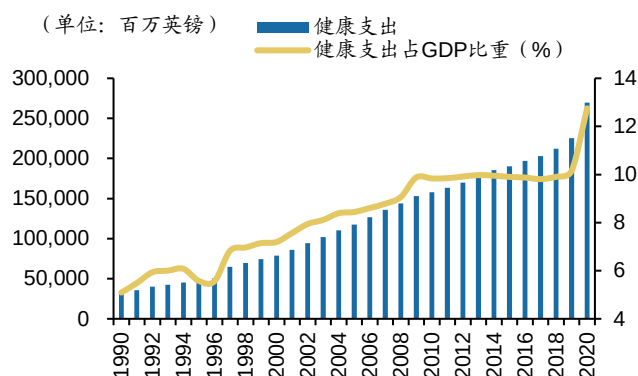
2.从经费筹集来看：财政收入是大头，居民负担较低

英国是NHS主导的医疗保障体系，绝对部分医疗费用由政府财政承担，同时全科医生隶属于国家卫生局，医院主要以公立机构为主，因为对于医疗资源有着绝对的主导权，对机器设备、新型技术开发和传播的投资严格控制和管理，使全社会的卫生费用保持了较低的水平，

从费用的筹集方式来看，英国卫生费用来源主要是财政收入，财政收入占总卫生经费的80%以上（数据来源：OECD），医疗和预防保健服务方面基本上采取免费享

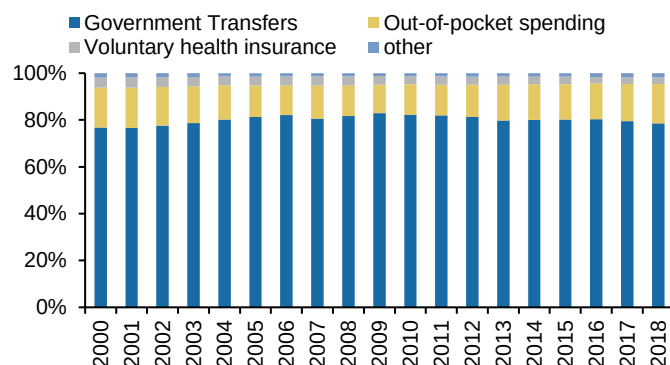
受服务，而仅仅是需要患者支付药剂费、部分牙科、自费病床、特需病床及外国人医院服务的费用，居民整体享受免费程度非常高的医疗卫生服务。

图2：英国医疗卫生费用支出



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

图3：英国医疗体系资金主要来源于公共资金



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

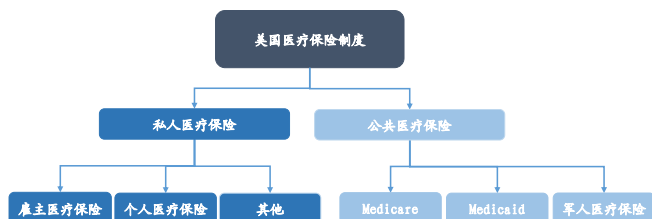
（二）美国：商业医疗保险制度

1. 医疗保险制度：以私人医疗保险为主

美国是发达国家中唯一没有实行全民健康保险或国家卫生服务制度的国家，医疗保障体系主要以商业医疗保险（私人医疗保险，PMI）和社会医疗保险，其中社会医疗保险包括老年医疗保险制度（Medicare）、医疗救助制度（Medicaid）、儿童健康保险计划（CHIP）等组成。私人医疗保险包括雇主医疗保险、个人医疗保险等。而公共医疗保险中，老人医疗保险为65岁以上老年人口、残疾人和终末期肾病患者提供医疗服务，包括医院保险服务、医疗保险服务、医疗优势计划和处方药计划等；医疗救助计划针对低收入群体的医疗健康保障项目，主要针对低收入的成年人、儿童、孕妇、65岁或以上人士、残疾人士等提供免费或者低成本的医疗福利，由美国联邦政府和各州政府共同资助，医疗救助采用联邦和州两级供款模式。

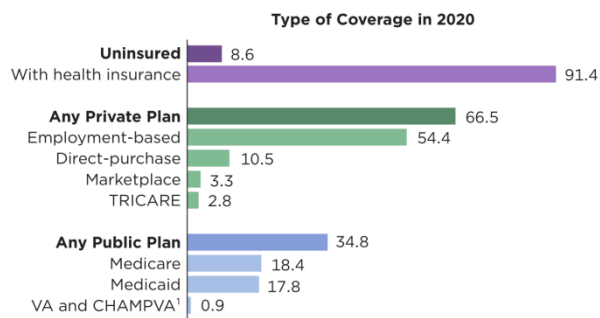
而美国是典型的自由市场经济国家，市场调节是资源的主要配置手段，卫生资源的配置主要以市场调节为主，私人医疗保险也是绝大多数普通美国人获得医疗保障的来源，2020年美国2.17亿人拥有私人保险，占总人口比重高达66.5%，其中雇主提供的保险占比54.4%，是最主要的医疗保险类型；而老人医疗保险制度覆盖5984.4万人，占比18.4%，医疗救助计划覆盖5792.1万人，占美国总人口比重17.8%，但仍有8.6%的人口是没有任何保险制度覆盖，较1999年的13.6%有所下滑（数据来源：美国人口统计局）。

图4：美国医疗保险体系



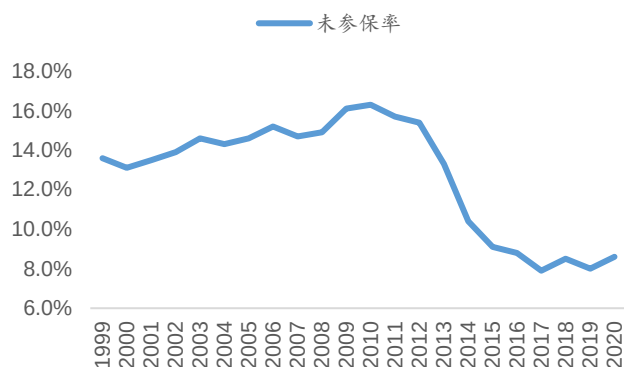
数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

图5：2020年美国医疗保险覆盖91.4%人群



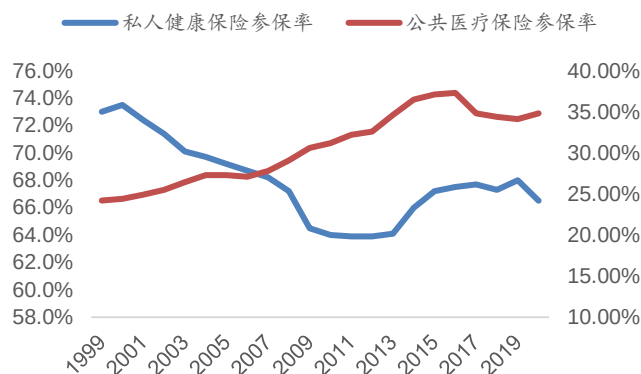
数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

图6：美国健康保险未参保率走势



数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

图7：美国公共和私人健康保险覆盖率



数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

美国社会医疗保险包括Medicare（老年人医疗保险）、Medicaid（医疗救助保险）、儿童健康保险和军人医疗保险等，覆盖人群较广的是Medicare和Medicaid。

Medicare制度建立于1965年，由联邦政府管理，各州实施统一政策，主要住院保险（A）、医疗保险（B）、医疗优惠计划（C）和处方药计划（D），其中A类为强制性计划，且不需要额外支付保费，主要包括住院服务、专业护理院费用、居家医疗费用、临终关怀机构费用等；B、C、D类计划属于自愿类性质，需要额外缴纳保险费。从Medicare历年的医疗费用的支出来看，医疗保险计划（B）逐步代替医院服务（A）成为最主要的支出计划（数据来源：美国CMS）。

Medicaid制度萌芽于20世纪30年代，正式实施于1965年，是由联邦政府和各州政府共同资助，采用联邦和州两级供款模式，联邦政府出台医疗服务的提供、质量标准、自主标准和参加者的资格要求，而州政府对受益对象的设定范围和给付内容做具体的要求和规范。目前美国50个州全部参加了该项目，关于参保人的资格，各州间的规定差别很大，除了属于低收入群体外，还必须满足一定的条件要求，比如年龄、妊娠状况、残障、失明、收入和财产、是否是美国公民、是否是合法移民等。其中均摊费用、护理机构费用、住院费用和医师服务费用是Medicaid中最主要的医疗费用支出项目（数据来源：美国CMS）。

表2: 美国公共医疗保险制度

	Medicare (老年医疗保险制度)	Medicaid (低收入医疗救助) 和 CHIP (儿童健康保险)
对象	1.65 岁以上老人、残疾人士、终末期肾病患者 2.美国公民或者永久居民, 缴纳 10 年或者 40 个季度以上的医疗保险税	符合条件的低收入个人、儿童和家庭 (每个州的标准不一样)
保障内容	Medicare A (医院保险): 报销医院的住院护理, 包括急诊和专业护理机构。缴纳足额税率 (2.9%) 的人 65 岁以后自动加入 Medicare A。每年的责任负担额为 1484 美元, 则报销 60 日内的全额住院费用、61-90 天为每日超过自负额 371 美元以外的住院费用报销; 91 天以后的自负额为每日 742 美元。 Medicare B (医疗保险): 医生的服务和门诊护理。自由加入, 每年缴纳 203 美元的责任负担额, 则报销 80% 医生服务和门诊护理费用 Medicare C (医疗优惠计划): 自由加入, 费用根据不同的计划而不同 Medicare D (处方药计划): 需要加入 Medicare 药物承保的计划, 需要另外支付保费。自由加入, 不同的计划不同的保费, 且若收入高于计划上报的则要另外增加保费。	住院服务给付、门诊服务给付等继各州独自的服务给付, 包括眼科、牙科、预防、复健等各种医疗救助服务种类等

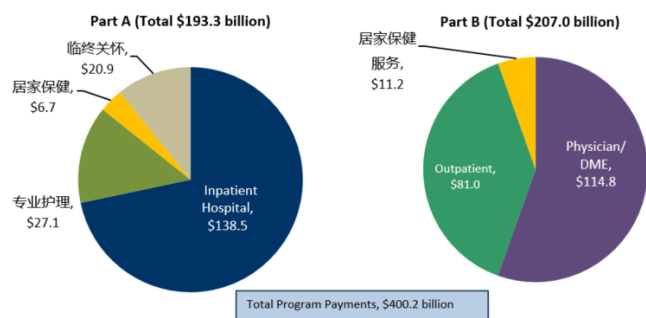
数据来源: 美国公共健康管理中心, 广发证券发展研究中心

表3: 美国Medicare医疗费用支出结构

十亿美元	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Medicare 支出总额	341.4	344.8	346.4	350.1	359.9	368.7	377.0	389.5	400.2
Medicare A (医院保险)	180.2	178.3	179.3	178.8	181.9	185.5	188.1	190.7	193.3
住院服务	128.9	128.6	129.2	128.5	130.0	133.4	135.3	137.0	138.5
专业护理设施	30.5	27.7	28.3	28.6	29.1	28.4	28.1	27.7	27.1
居家保健服务	13.9	15.1	15.1	15.1	15.9	16.8	17.9	19.3	6.7
临终关怀	6.9	6.8	6.8	6.6	6.9	6.9	6.8	6.8	20.9
Medicare B (医疗保险)	161.3	166.5	167.1	171.3	178.0	183.2	188.9	198.8	207
医师和其他医疗服务	98.4	100.1	98.6	99.1	102.2	103.8	105.6	109.9	114.8
门诊服务	51.2	55.1	57.3	61.2	64.4	68.2	72.3	77.8	81
居家保健服务	11.6	11.3	11.2	11.1	11.3	11.3	11.0	11.1	11.2

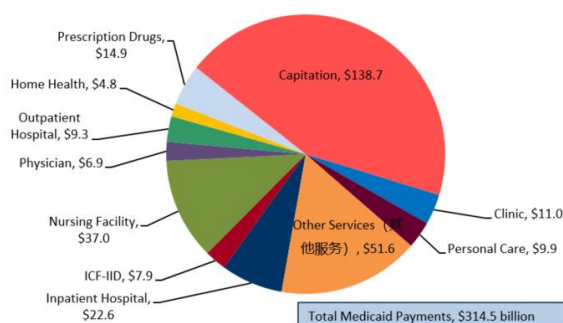
数据来源: 美国 CMS, 广发证券发展研究中心

图8: 2019年美国Medicare医疗费用支出结构



数据来源: 美国 CMS, 广发证券发展研究中心

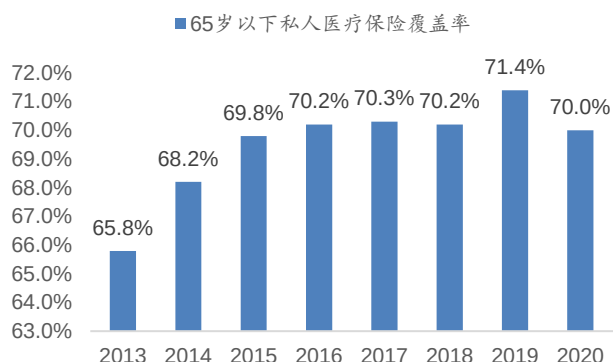
图9: 2019年美国Medicaid医疗费用支出结构



数据来源: 美国 CMS, 广发证券发展研究中心

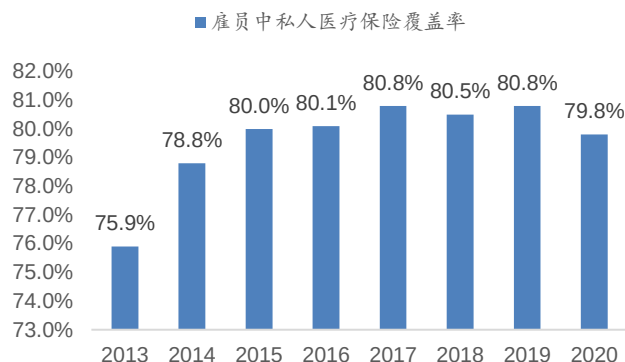
由于社会医疗保险覆盖的人口有限（2020年占比仅34.8%），美国商业医疗保险制度愈显发达，覆盖全美66.5%的人口，包括雇主购买的医疗保险、个人医疗保险和其他等。据美国人口统计局的数据显示，2020年美国65岁以下70%的居民是商业医疗保险的投保人，而19-64岁人口占比更高达73%。商业医疗保险大部分被当作企业福利措施之而实施，几乎所有的大企业都为雇员购买商业医疗保险，2020年美国雇员中79.8%拥有商业医疗保险，全职工作者的比重相对更高（87%）。雇员医疗保险是商业医疗保险最主要的种类，2020年美国私人医疗保险渗透率为67.3%，其中雇主购买的医疗保险渗透率为54.4%，而个人直接购买的医疗保险渗透率为10.5%。

图10：美国65岁以下私人医疗保险覆盖率



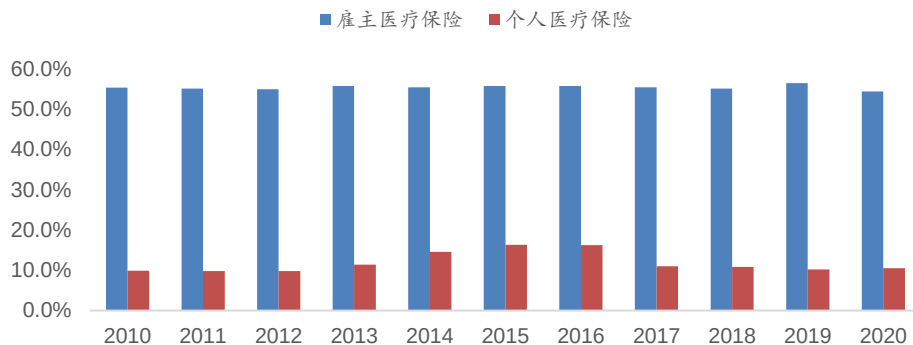
数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

图11：美国劳动人口拥有的私人医疗保险比例



数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

图12：私人医疗保险种类覆盖率



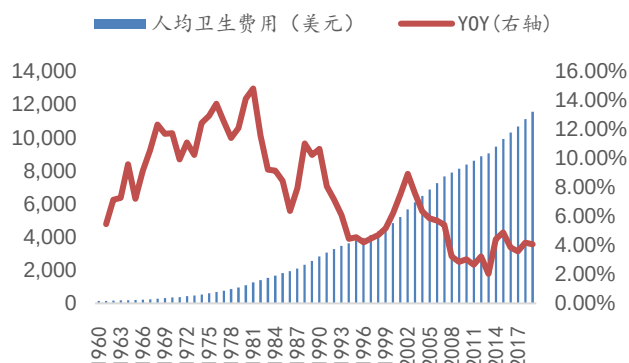
数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

2. 医疗费用支出情况：逐年提升且远高于其他国家

美国是世界上医疗费用最高的国家，远远高于其他发达国家，门诊服务、急诊服务、住院费用均较高。2020年美国卫生费用3.8万亿美元，自1960年以来复合增速高达8.7%，人均卫生费用为11582美元，1960年以来CAGR为7.7%，59年来保持较高的增长。卫生费用的增速超越GDP的增速，因此导致卫生费用占GDP的比重持续提升，2020年达到17.7%，远高于全球水平，且高于其他发达国家，且高于欧洲高福利国家的瑞士，是全民医疗保险制度的英国两倍有余（数据来源：wind和WHO）。

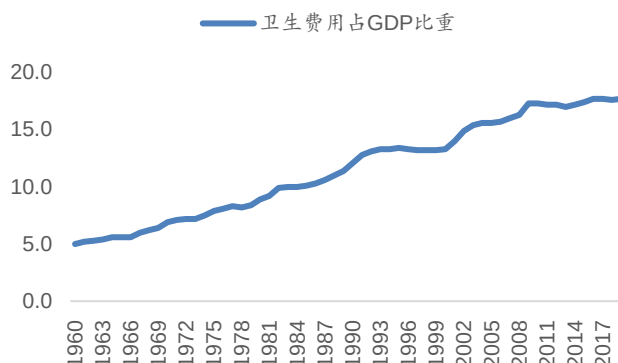
美国卫生费用的持续增长和医疗保险参保人数增加和对医疗供给方的支付水平偏高有关。

图13: 美国人均卫生费用及同比增速



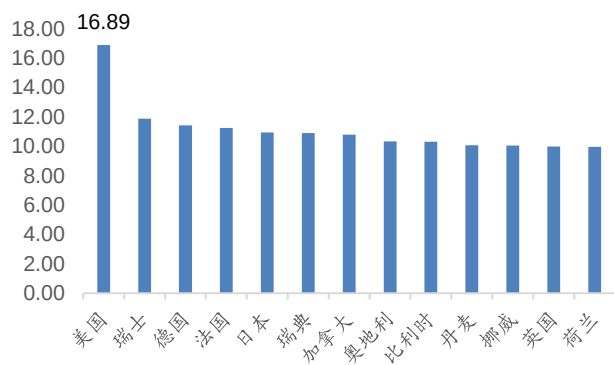
数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图14: 美国卫生费用占GDP比重逐年提升



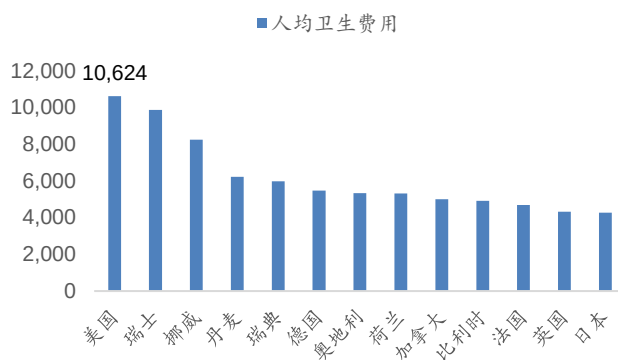
数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图15: 2018年成熟国家卫生费用支出占GDP比重(%)



数据来源: WHO, 广发证券发展研究中心

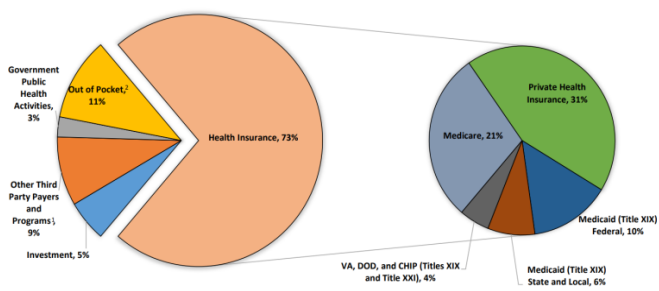
图16: 2018年成熟国家人均卫生费用支出(美元)



数据来源: WHO, 广发证券发展研究中心

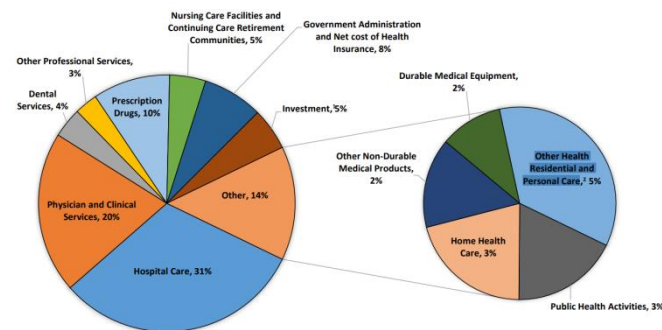
从医疗费用的来源看，医疗保险是最主要的支付方，2019年贡献73%的医疗费用来源，其中私人医疗保险占比31%，较1960年的20.8%提高10个百分点；而公共医疗保险贡献42%（Medicare21%、Medicaid联邦资金10%、Medicaid州政府6%、其他公共医疗保险4%）；而个人现金支出占比仅为11%，相较于1960年的47.1%大幅下滑。从医疗费用的结构来看，医院费用占比最大，其次是医生的服务费，2020年二者共同占比51%，较1998年的60.1%略有下行，其次是处方药（10%）、护理费用（5%）、护士费用（5%）等（数据来源：CMS）。

图17：2019年美国医疗费用来源



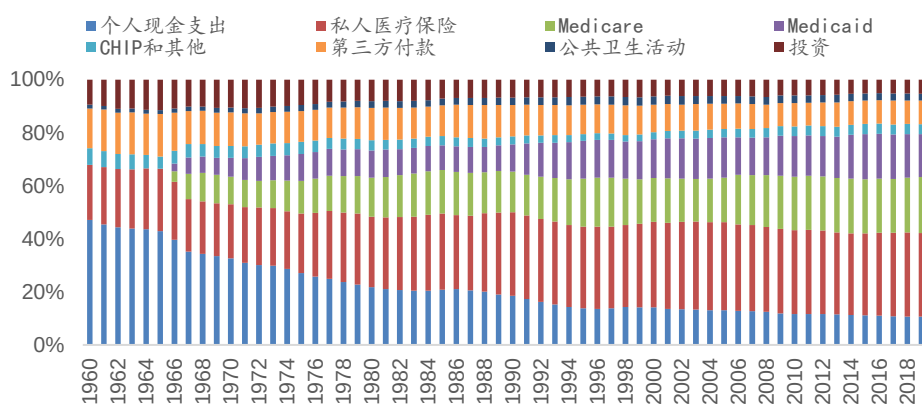
数据来源：CMS，广发证券发展研究中心

图18：2019年美国医疗费用明细



数据来源：CMS，广发证券发展研究中心

图19：美国医疗费用来源结构



数据来源：CMS，广发证券发展研究中心

（三）德法日：社会医疗保险制度

1. 德国医疗保险制度

社会医疗保险制度以国家强制的原则筹集国家大部分的医疗费用，采取市场和计划相结合，卫生费用主要来源于社会保险，且覆盖人群相对较高。德国是世界上第一个建立法定医疗保险制度的国家，于1883年、1884年、1889年分别颁布了疾病保险法、意外伤害保险法、伤残老年保险法等，目前德国整体的医疗保险制度是以法定医疗保险为主，私人医疗保险为辅的社会医疗保险制度。德国法定医疗保险是作为社会责任共同体，保持和恢复参保人的健康或改善其健康状况，为参保人提供全面的医疗健康管理费用，根据实物待遇原则（医疗保险经办机构和医院、医生结算）、共济原则（保险费和收入挂钩）、自我管理原则等。

表4: 德国法定医疗保险制度

主要内容

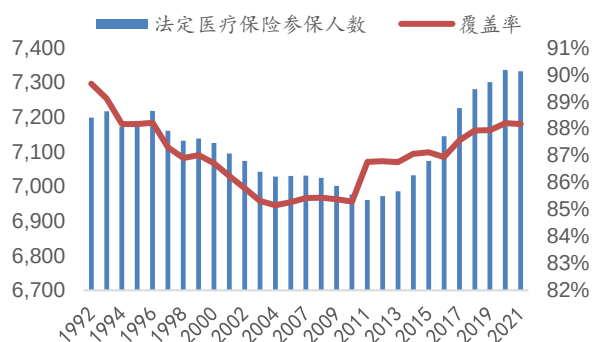
覆盖人群	1.月收入低于 455 欧元, 或者年收入低于 6.255 万欧元;
	2.大学生
	3.领取失业救助金的失业人员
	4.农民
保险费率	14.6%, 雇主和雇员各负责一半
保障内容	1.预防费用, 包括体检、预防性牙科等;
	2.疾病医疗保障, 包括医疗费用、疾病津贴、康复费用等;
	3.生育医疗保障, 包括医疗费用、生育津贴等;
	4.心理治疗费用

数据来源: 德国联邦劳动和社会管理局, 广发证券发展研究中心

法定医疗保险采取强制性手段, 参加医疗保险作为一项义务, 覆盖了德国大部分的人口, 且2009年以后全国统一保险费率(2020年费率为14.6%), 雇主和雇员、养老金领取者和养老保险基金各承担一半的费率。截至2020年6月底, 德国法定医疗保险覆盖7331.9万人, 占德国总人口的88.2%, 一直维持着较高的渗透率(数据来源: 德国社会保障局)。

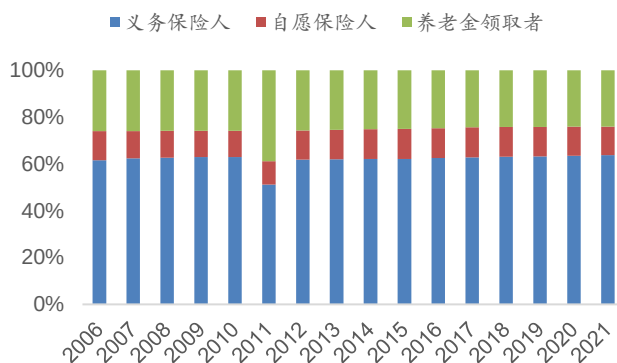
参保人员分为义务保险者、自由保险者、家庭成员, 义务保险者是年收入低于6.255万欧元的就业者、失业者、领取养老金的退休人员、大学生和就业务前的实习生等, 均需要参加法定医疗保险, 而高于以上标准的是自由保险者, 自由保险者可选择法定医疗保险, 也可以参加私人医疗保险, 若参保人的配偶及子女月收入未超过标准, 无须支付法定医疗保险费可被纳入家庭联保(数据来源: 德国社会保障局)。

图20: 德国法定医疗保险参保人数和参保率(万人)



数据来源: 德国社会保障局, 广发证券发展研究中心

图21: 德国法定医疗保险参保结构

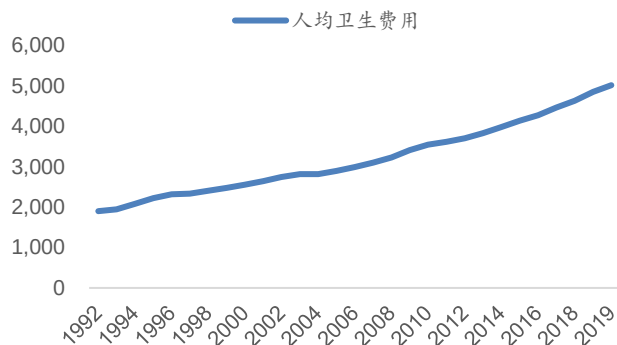


数据来源: 德国社会保障局, 广发证券发展研究中心

法定医疗保险保障内容非常全面, 卫生费用持续增长且占GDP比重较高。法定医疗保险的保障范围包括疾病预防、疾病治疗、康复等全流程, 其中包括1.早期疾病预防和诊断; 2.疾病医疗保障, 包括治疗费用、病假津贴(先雇主支付6周, 后续由法定保险支付工资的70%, 最多可以领取78周), 资料来源德国社会保障局); 3.生育医疗保障, 包括生育过程的医疗卫生费用、产妇产津贴和分娩津贴等; 4.心理治疗等。在保障范围较广之外, 德国居民在使用卫生服务时的费用主要有第三方支付, 因而

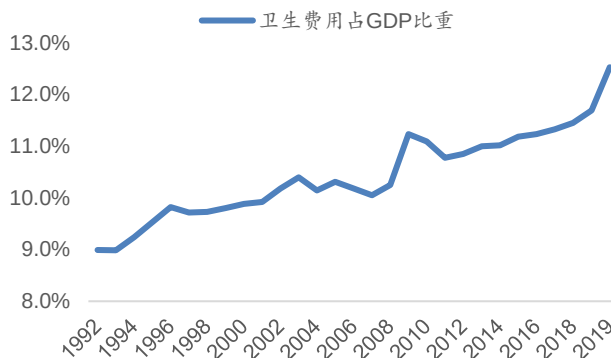
患者和医生都缺乏费用意识，医疗机构的竞争主要表现在服务数量和智联搞得竞争，因此德国的卫生费用持续增长，2020年德国卫生费用支出总额为4175.4亿欧元，较1992年CAGR为3.6%，人均卫生费用由1992年的1901.7欧元提升至如今的5020.5欧元，占GDP比重由9%提升至12.5%（数据来源OECD），处于全世界较高的水平。从2019年支出结构来看，其中护理和治疗费用、医疗器械和医疗服务费用的支出最大，分别占比为30%、26.8%、25.6%（数据来源联邦预算委员的健康报告）。

图22：德国人均卫生费用及同比增速（欧元）



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

图23：德国卫生费用占GDP比重逐年提升



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

表5：德国卫生费用支出结构

	1992	2000	2005	2010	2016	2017	2018	2019
预防/健康保险	3.9%	3.5%	3.6%	3.6%	3.5%	3.4%	3.4%	3.5%
医疗服务	29.2%	27.3%	27.2%	27.1%	26.8%	26.2%	25.9%	25.6%
护理/治疗服务	21.9%	25.6%	25.3%	25.9%	27.7%	29.2%	29.7%	30.1%
住宿和餐饮	8.9%	8.9%	8.6%	7.9%	7.6%	7.4%	7.3%	7.4%
货物	29.6%	27.6%	28.0%	28.3%	27.7%	27.0%	26.8%	26.8%
运输	1.3%	1.7%	1.7%	1.8%	2.0%	2.0%	2.1%	2.2%
行政服务	5.2%	5.5%	5.6%	5.4%	4.8%	4.7%	4.7%	4.4%

数据来源：德国联邦健康报告，广发证券发展研究中心

德国法定医疗保险保障内容全面，且保障程度也相对较高，医疗费用中个人费用分担的比例较低，且有全年最高的支付限制，自付的上限是家庭总收入的2%，若罹患癌症的患者则上限为1%，并且儿童具备免税额。受益德国法定医疗保险的覆盖较广、程度较高，因此居民的医疗健康负担较低，2019年卫生费用支出4034.4亿欧元中，财政支出、法定医疗保险、商业健康险和个人分别占比12.8%、64.9%、8.3%、12.8%（数据来源联邦预算委员的健康报告）。

表6: 德国法定医疗保险参保人医疗费用自付明细

自付种类	自付比例
药品费	费用的 10%，最低 5 欧元，最高 10 欧元
敷料费	费用的 10%，最低 5 欧元，最高 10 欧元
交通费	交通费的 10%，每次最低 5 欧元，最高 10 欧元
治疗费	费用的 10%，外加 10 欧元的处方费
救援费	费用的 10%，最低 5 欧元，最高 10 欧元
医疗耗材辅助费	费用的 10%，每月最高 10 欧元
住院治疗费	每天 10 欧元，一年内最高支付 28 天
门诊康复费用	每天 10 欧元

数据来源：德国联邦社会保障局，广发证券发展研究中心

表7: 德国卫生费用经常支出账户收入来源结构

	1992	2000	2005	2010	2016	2017	2018	2019
政府财政支出	21,819	21,633	29,661	44,486	48,831	49,624	50,107	51,748
社会保险	99,658	141,463	148,906	170,898	223,339	237,416	248,002	261,832
商业健康险	10,592	16,402	20,661	25,461	29,946	30,556	32,206	33,497
现金支付	17,305	25,628	33,318	39,722	45,736	47,188	49,343	51,707
其他	3,710	3,424	3,413	3,970	4,356	4,536	4,664	4,659
合计	153,084	208,550	235,959	284,537	352,208	369,320	384,322	403,443
政府财政支出	14.3%	10.4%	12.6%	15.6%	13.9%	13.4%	13.0%	12.8%
社会保险	65.1%	67.8%	63.1%	60.1%	63.4%	64.3%	64.5%	64.9%
商业健康险	6.9%	7.9%	8.8%	8.9%	8.5%	8.3%	8.4%	8.3%
现金支付	11.3%	12.3%	14.1%	14.0%	13.0%	12.8%	12.8%	12.8%
其他	2.4%	1.6%	1.4%	1.4%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%

数据来源：德国联邦健康报告，广发证券发展研究中心

（四）新加坡：储蓄医疗保险制度

新加坡政府的医疗保险制度是典型的储蓄型保险，医疗保险以全民保健储蓄计划（Medisave）、个人综合型终身医疗保险（IPs,终身健保计划Medishield Life和私人医疗保险）等。新加坡政府卫生政策的指导思想是推广健康生活，提倡个人对自己的健康负责，避免过分依赖国家福利或医疗保险，且传统观念注重家庭在社会保障中所起的作用，因此建立了以个人储蓄为主的社会保障制度。在个人储蓄为主的医疗保险制度下，若公民或者永久居住者没有保健储蓄账户和IPs,个人无力支付医疗费用，可以申请医疗救助，主要是政府设立的保健基金（Medifund）对符合救济的患者承担相应的医疗费用。

全民保健储蓄计划于1993年7月1日实施，是全国性的强制储蓄计划，要求雇员和自雇者都应遵循法律的规定参加保健储蓄计划。保健储蓄计划是新加坡中央公积金制度的其中一个账户，中央公积金制度建立于1995年，强制所有雇主、雇员和自雇者按照工资收入的一定比例向中央公积金局缴纳公积金，公积金包括三个账户：普通

账户（退休储蓄、住房需求、投资和教育储蓄，剩余资金用于退休）、特别账户（限于养老和特殊情况下的紧急支付）、保健账户（住院医疗费用和重大疾病医疗保险），从2016年以来，参加工作的居民在55岁以下缴费率为37%，而55岁以上缴费率递减，65岁以上缴费率为12.5%，而自雇人员在年收入6000新币以上也必须缴费，但每年存在缴费上限（数据来源：新加坡CPF）。

表8：新加坡中央公积金缴费率

年龄	雇佣者缴费率			自雇者缴费率				
	普通账户	特别账户	保健账户	收入情况（新元）	35岁以下	35-45岁	45-50岁	50岁以上
35岁以下	23.0%	6.0%	8.0%	6000-12000	4%	4.50%	5%	5.25%
35-45岁	21.0%	7.0%	9.0%	12000-18000	4%-8%	4.5%-9%	5%-10%	5.25%-10.5%
45-50岁	19.0%	8.0%	10.0%	18000以上	8%	9%	10%	10.50%
50-55岁	15.0%	11.5%	10.5%		Max5760	Max6480	Max7200	Max7560
55-60岁	12.0%	3.5%	10.5%					
60-65岁	3.5%	2.5%	10.5%					
65岁以上	1.0%	1.0%	10.5%					

数据来源：CPF，广发证券发展研究中心

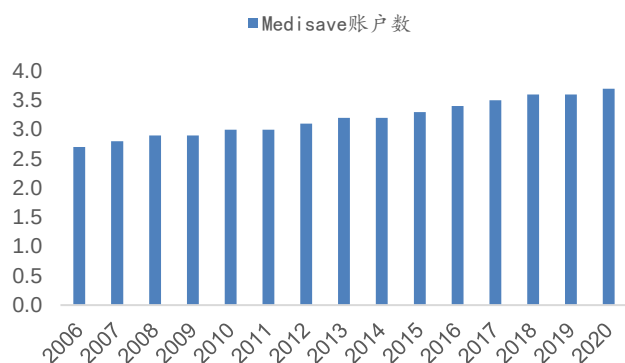
表9：保健账户使用的医疗费用和单项费用扣款上限

Medisave	项目	提款限额
急诊住院费用	住院费用	住院前两天是 550 新元/日；住院期间是 400 新元/日
	范围内的手术日	300 新元/日
	精神病住院费用	住院前两天是 550 新元/日；住院期间是 150 新元/日，全年上限 5000
门诊费用	高血压、高血脂、脂质紊乱（如高胆固醇）、中风、哮喘、慢性阻塞性肺疾病、抑郁症、精神分裂症等慢性病门诊	罹患复杂慢病者 700 新元/年；罹患非复杂慢病者 500 新元/年；15%的现金共同支付适用于经批准的慢性病治疗
	社区医院	250 新元/日，全年上限 5000
	日间医院	150 新元/日，全年上限 3000
康复护理	日间康复中心	25 新元/日，全年上限 1500
	疗养医院	50 新元/日，全年上限 3000
临终关怀	住院和家庭保守治疗	

数据来源：CPF，广发证券发展研究中心

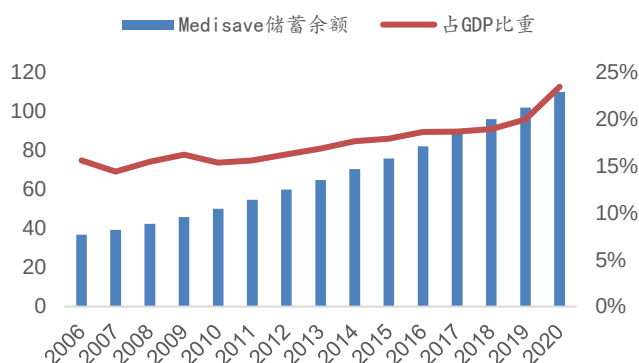
保健账户的资金可用作本人和家庭成员支付住院、门诊、康复和临终关怀等费用，但设置单项医疗费用的扣款上限，避免因储蓄过多造成的医疗需求不适宜的增大和医疗资源的浪费。截至2020年，全国Medisave账户共有370万，且储蓄余额为1101亿新元，较2006年复合增速为8.1%，保持相对较高的增长（数据来源新加坡卫生部）。

图24: 新加坡保健账户数 (百万)



数据来源: 新加坡卫生部, 广发证券发展研究中心

图25: 新加坡保健账户余额及占GDP比重 (十亿新元)



数据来源: 新加坡卫生部, 广发证券发展研究中心

终身健保计划 (Medishield Life) 是一项基本医疗保险计划, 由中央公积金委员会管理, 帮助支付大额医院账单和部分昂贵的门诊治疗费用, 如癌症透析和化疗, 但如救护车费用、整容手术、牙科、产妇费用、私人护理等方面的医院和门诊费用等不属于终身健保的赔付范围之内。终身健保计划自2015年实施, 取代健保双全计划, 覆盖所有的新加坡公民和永久居民, 真正达到全民覆盖, 且相较于健保双全计划, 终身健保的保额更高、费率更低, 且终身健保的保费可以由保健账户全额支付, 不同的年龄的费率不同, 但整体相对较为便宜, 如30岁的居民所需缴纳的年度保费为195/250新元。(数据来源新加坡卫生部)

表10: 终身健保计划赔付范围和限额

住院和手术费用	普通病房 800 新元/日; 重症监护病房 2200 新元/日; 社区医院 (康复) 350 新元/日; 社区医院 (亚急性) 430 新元/日; 住院保守治疗 (一般) 250 新元/日; 住院保守治疗 (专科) 350 新元/日;
	外科手术
门诊费用	癌症化疗、放射治疗等; 肾透析; 器官移植免疫剂等
保额	15 万新元
保险期间	终身

数据来源: 新加坡卫生部, 广发证券发展研究中心

表11: 终身健保计划的费率情况 (新元)

年龄	2021年3月31日前生 效的保单	2021年3月31日后生 效的保单	年龄	2021年3月31日前生 效的保单	2021年3月31日后生 效的保单
1-20 岁	130	145	74-75 岁	975	1,320
21-30 岁	195	250	76-78 岁	1,130	1,530
31-40 岁	310	390	79-80 岁	1,175	1,590
41-50 岁	435	525	81-83 岁	1,250	1,675
51-60 岁	630	800	84-85 岁	1,430	1,935
61-65 岁	755	1,020	86-90 岁	1,500	2,025
66-70 岁	815	1,100	90 以上	1,530	2,055
71-73 岁	885	1,195			

数据来源: CPF, 广发证券发展研究中心

私人医疗保险是额外的私人保险公司提供的额外的医疗保险保障，终身健保可以覆盖大部分的医院费用和医院B2和C型病房，但私人医疗保险通常涵盖公立医院或私立医院的A/B1类型病房和昂贵的门诊治疗，补充了终身健保的不足的地方，提供更高的理赔上限和保障范围（如友邦提供的私人医疗保险最高保额可达到200万新元，而终身健保保额金15万新元），且可以自己选择医生，而终身健保不可以自由选择医生。截至2020年，新加坡有283万人购买了私人医疗保险，占新加坡总人口49.8%，较2006年的34.3%明显提升（数据来源新加坡卫生部）。

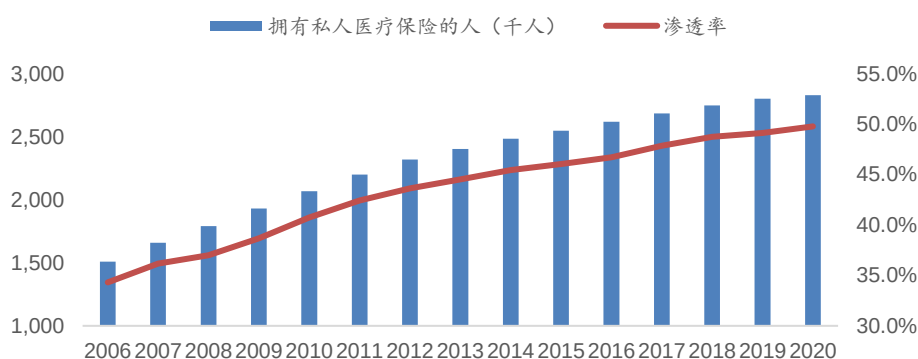
私人医疗保险的保费由承保的商业保险公司指定，目前承保的商业保险公司有7家（友邦保险、英杰华保险、安盛保险、大东方人寿保险、NTUC保险、保诚、莱佛士健康保险），中央公积金会员可以使用Medisave账户余额为自己和家人（父母、配偶、子女和兄弟姐妹等）支付保费，但每个人只能支付终身健保或者私人医疗保险的其中一项保费，但可以支付其他家庭成员的终身健保或者私人医疗保险费用。

表12: 友邦保险HealthShield Gold Max产品报销范围

住院及手术津贴	病房费用，包括医院的套房、VIP 病房等费用； ICU 费用； 社区医院费用； 手术费用；
精神治疗津贴	精神病住院费用 (a) 癌症放射治疗 (b) 癌症立体定向放射治疗
门诊津贴	(c) 癌症化疗 (d) 肾透析 (e) 促红细胞生成素 (f) 经卫生科学局批准，在器官移植后向投保人开具的免疫抑制剂

数据来源：CPF，广发证券发展研究中心

图26: 新加坡私人医疗保险参保人数和渗透率



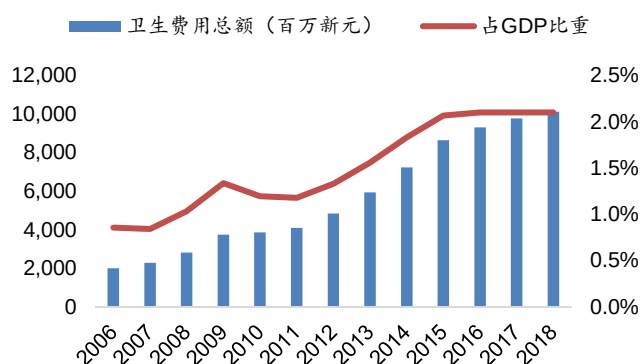
数据来源：新加坡卫生部（MOH），广发证券发展研究中心

从卫生费用来看，新加坡卫生费用占GDP的比重相对较低，远低于其他成熟国家。截至2018年，新加坡卫生费用为101.23亿新元，较2006年复合增速为14.4%，占GDP比重仅为2.1%，较2006年的0.9%有所提升（数据来源：新加坡卫生部），但仍明

显低于美国、德国等国家，一方面人口结构相对成熟发达国家年轻，另外是新加坡的医疗费用控制机制，包括以公立医院为主的医疗体系，且药品采购等方式降低费用，另外就是对保健账户支付医疗费用的单项进行上限控制，有效的约束医疗供需双方的行为，抑制医疗支出。

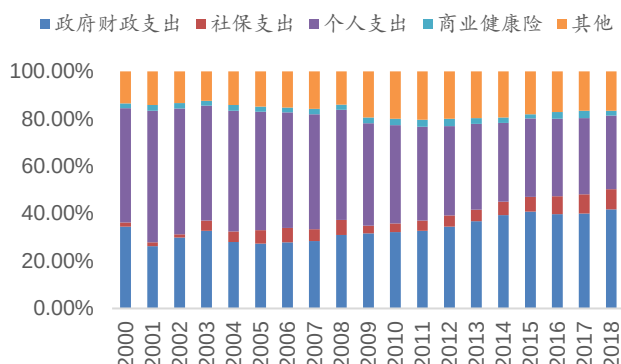
从卫生费用来源结构看，新加坡由于采用个人储蓄的医疗保险体系，因此私人资金来源占比相对较高，截至2018年，新加坡卫生费用来源主要包括财政支出和个人支出，占比分别为41.87%和31.04%，二者合计占比72.9%（数据来源：WHO），财政支出主要是以保健基金的方式救助收入较低，且没有保健账户和个人综合医疗保险的居民，而个人支出包括保健账户、健保终身共付和现金支付的部分。

图27：新加坡卫生费用占GDP比重为2.1%



数据来源：新加坡卫生部，广发证券发展研究中心

图28：新加坡卫生费用来源结构



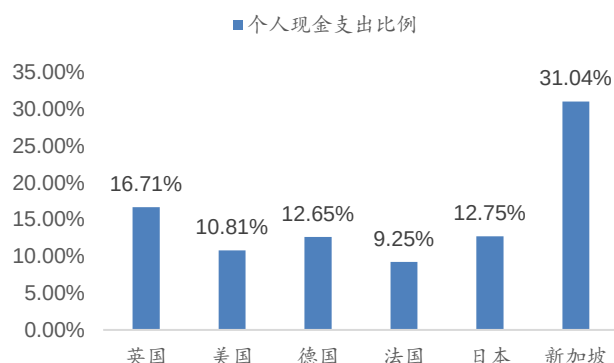
数据来源：WHO，广发证券发展研究中心

（五）成熟经济体的医保制度的共性：降低居民医疗支出成本

从上述分析的全球主要医疗保险制度的结果看，无论是国家卫生制度、商业医疗保险制度、社会医疗保险制度，主要的作用便是在人口结构的变化过程中，医疗费用的不断上涨背景下，降低居民的个人现金支出比例，提高居民抵抗疾病的风险，使居民能够获得更好的医疗健康服务（新加坡的储蓄医疗制度除外，强调个人储蓄在医疗制度方面的作用）。

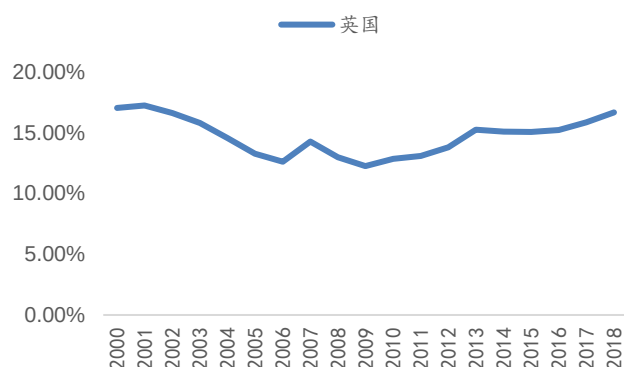
从世界卫生组织公布的数据来看，2018年英国、美国、德国、法国、日本、新加坡卫生费用中个人现金支出比例分别为16.7%、10.8%、12.7%、9.3%、12.8%、31%。而纵向来看，英国个人支出占比由2000年的17.1%下降至2018年的16.7%，而美国由1960年的47.1%下降至2019年的10.7%，而德国由1970年的14.6%下降至2019年的12.7%；法国由1970年的18%下降至2019年的9.3%；日本由1995年的14.5%下降至2019年的13%（数据来源：WHO和OECD）。

图29：2018年成熟国家卫生费用中个人支出比重



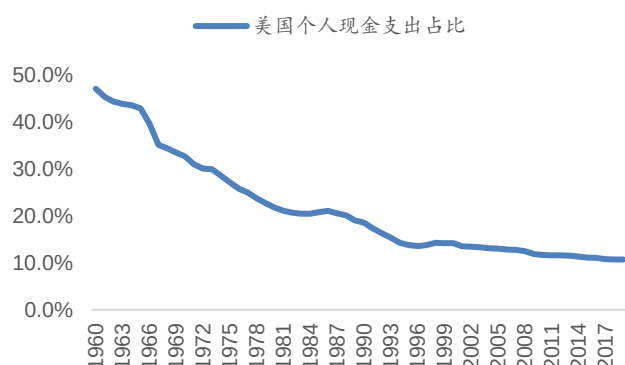
数据来源：WHO，广发证券发展研究中心

图30：英国卫生费用支出中个人现金占比



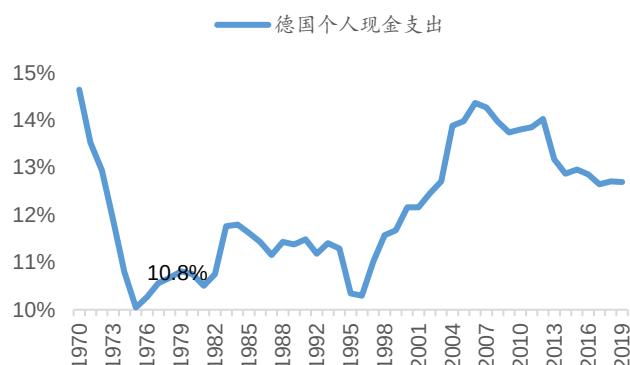
数据来源：WHO，广发证券发展研究中心

图31：美国卫生费用支出中个人现金占比



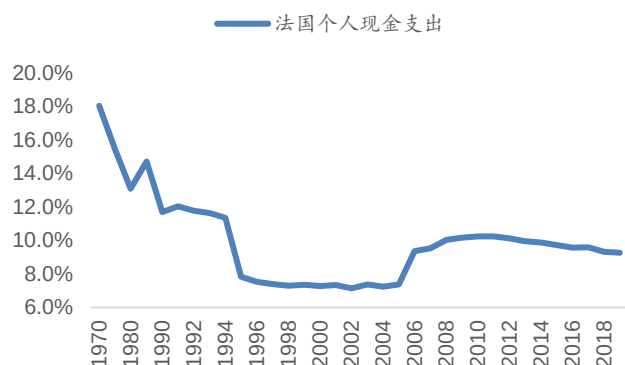
数据来源：广发证券发展研究中心

图32：德国卫生费用支出中个人现金占比



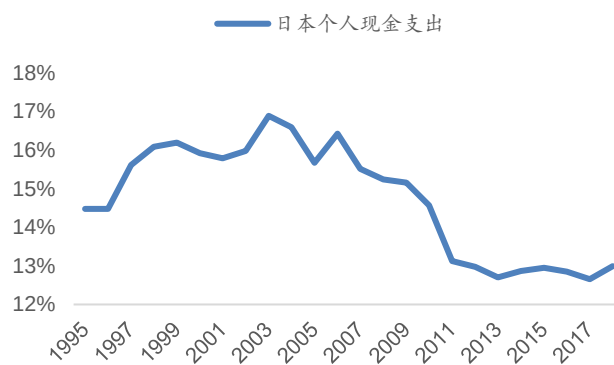
数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

图33：法国卫生费用支出中个人现金占比



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

图34：日本卫生费用支出中个人现金占比



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

二、成熟国家人身险产品结构

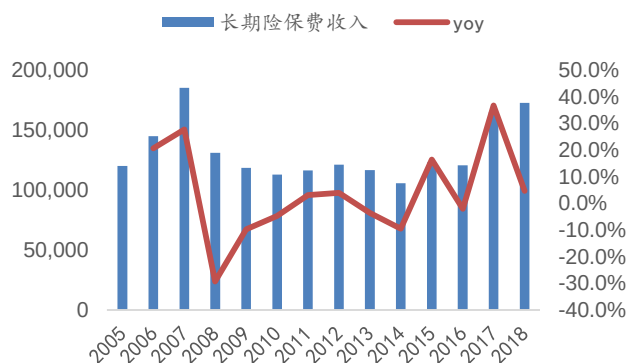
（一）英国：养老金为主的人身险行业

英国作为全球第四大保险市场，也是欧洲最大的保险市场，2019年占全球总保费份

额5.82%仅次于美国、中国和日本（数据来源：瑞士再保险），英国因全民医疗保险制度，享受较好的医疗服务，因此人身保险行业产品结构以年金险为主，主要包括寿险、个人养老金、职业养老金、保障类（包括收入保障险、给付型重疾险等）等。2018年英国人身险行业长期险保费规模为1728.1亿英镑，同比增长4.7%，较2005年增速为2.8%，保费增速相对缓慢（数据来源：ABI）。

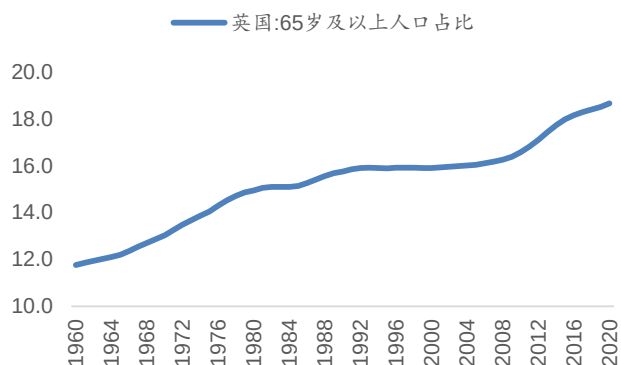
从产品结构来看，2018年职业养老金、个人养老金、寿险、重疾险规模分别为1105.8亿英镑、494.6亿英镑、102.8亿英镑、24.9亿英镑，占比分别为64%、28.6%、5.9%、1.4%，较2005年变化来看，养老金占比明显提升，由2005年的67.9%提升至92.6%，预计和英国人口开始老龄化有关，65岁以上人口占比自2005年的16%提升至2020年的18.65%，而保障类产品规模和占比保持相对稳定。据英国保险业协会的数据显示，2017年个人保障类产品规模保持稳定，但团体保障类产品实现较快的增长，表明雇主开始为雇员提供有价值的保护，包括团体保护计划、团体重疾险、团体收入保护险等。2017年团体保护计划、团体重疾险、团体收入保护险参保人分别为910万、60万人、250万人，增速分别为9%、2%、23%（数据来源：ABI）。

图35：英国长期险保费收入及同比增速（百万英镑）



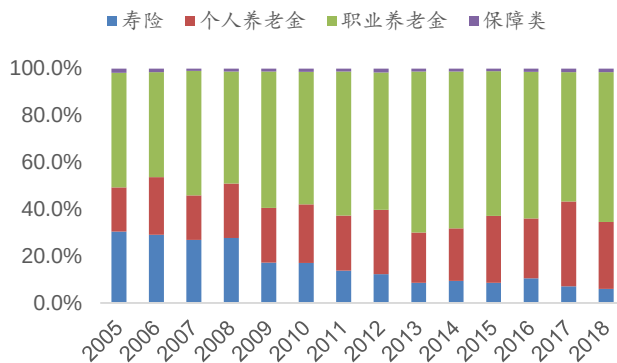
数据来源：英国保险业协会，广发证券发展研究中心

图37：英国65岁以上人口占比持续提升



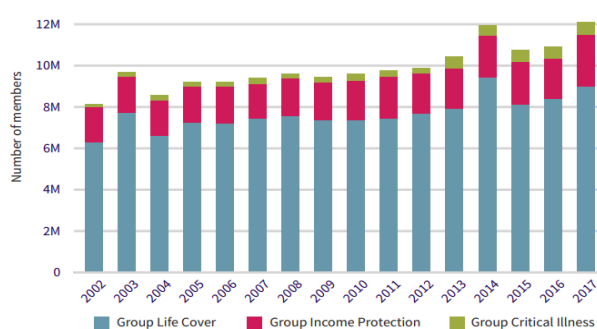
数据来源：wind，广发证券发展研究中心

图36：英国长期险以年金险为主



数据来源：英国保险业协会，广发证券发展研究中心

图38：团体保障类产品参保人数



数据来源：英国保险业协会，广发证券发展研究中心

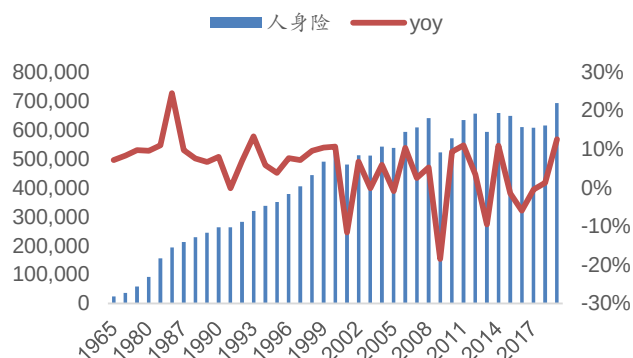
（二）美国：以寿险为主的产品结构

美国是全球第一大寿险市场，因人口老龄化和税优政策的推动，人身险行业以年金

险为主，但因商业医疗保险为主的医疗体系推动健康险的占比也相对较高。根据瑞士再保险的数据表明，2020年美国总保费占全球比重为40.3%，继续提升，其中寿险保费占全球比重为22.6%。根据美国人身险协会的数据显示，2019年美国人身险保费规模为6922.1亿美元，同比增长12.6%，1965-2019年复合增速为6.4%，维持相对较高的水平，人身险行业深度为3.2%（数据来源：ACLI）。

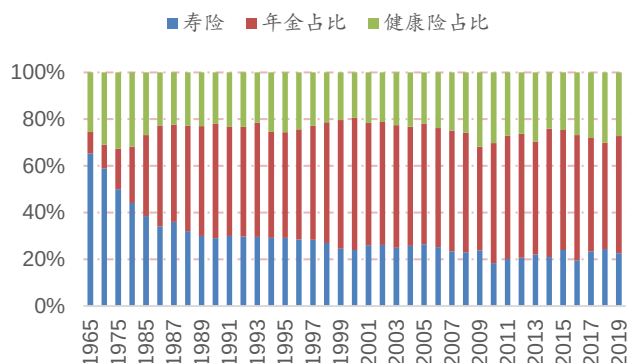
美国人身险产品包括寿险、年金险和健康险，其中寿险业务包括个人寿险和团体寿险业务，主要是定期寿险、终身寿险和分红；而年金险业务分为个人业务和团体业务，包括商业保险公司持有的养老金和退休计划；健康险以医疗险为主，还包括失能险和长期护理险。截至2019年，寿险、年金险、健康险占保费的比重分别为23%、50%、27%，较1965年的65%、9%、25%变化来看，年金险大幅提升，主要是在1974年建立传统个人退休账户，推动年金险的比重由1970年的10%提升至1975年的17%，1986年《税收改革法案》的推出进一步推动第三支柱的发展，年金险占比由1985年的35%提升至1986年的43%；而以医疗险为主的健康险占比维持在25%左右，主因美国公共医疗保险覆盖人群较少，仅针对65岁以上的老年人口和低收入人群，且美国的医疗支出较高，若不购买商业医疗保险则很难承担逐年高涨的医疗费用。（数据来源：ACLI）

图39: 美国人身险行业保费（百万美元）



数据来源：ACLI，广发证券发展研究中心

图40: 美国人身险行业产品结构



数据来源：ACLI，广发证券发展研究中心

表13: 美国健康险特殊险种的规模和占比（百万美元）

	2008	2009	2016	2017	2018	2019
失能险	20,410	20,117	24,772	25,641	26,384	27,588
长期护理险	9,553	10,467	11,399	11,457	11,412	11,518
牙医险	8,362	8,450	13,058	13,959	13,927	14,583
意外等保险	5,154	4,960	6,086	6,272	6,522	6,813
占健康险整体比重	26.3%	26.5%	33.7%	33.6%	31.4%	32.2%

数据来源：ACLI，广发证券发展研究中心

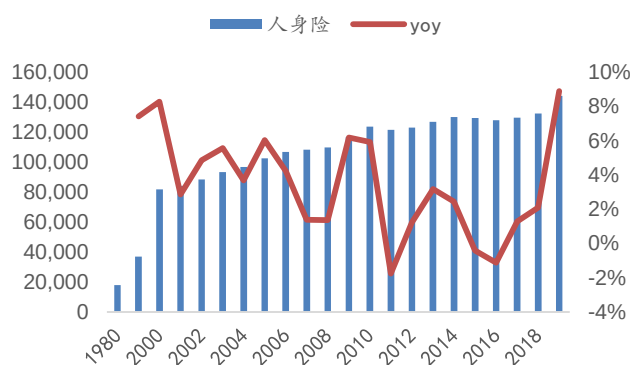
（三）德国：寿险为主的人身险产品结构，

作为社会医疗保险制度开山鼻祖的德国，商业保险市场也较为发达，也是全球第五

大保险市场(数据来源瑞士再保险), 2020年保险行业深度为6.8%(寿险深度2.8%)、保险行业密度为3108美元/人(寿险密度1281美元/人)。随着人口结构的变化, 德国人身险产品的结构也有所变化, 其中年金险产品占比提升, 综合医疗保险为主的健康险占比稳定在25%左右(数据来源: 德国保险业协会)。

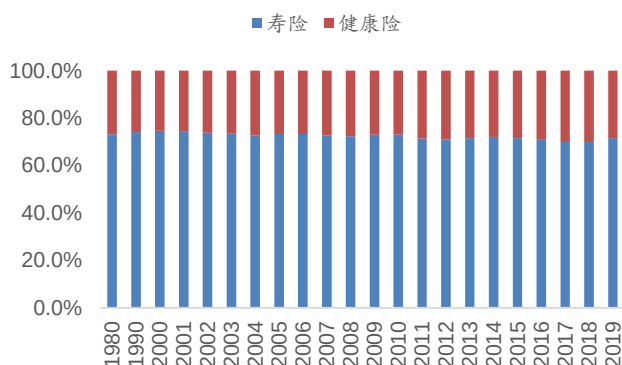
截至2019年德国人身险行业保费为1441.8亿欧元, 同比增长8.9%, 1980-2019年复合增速为5.5%, 其中寿险和健康险占比分别为71.6%、28.4%, 相较于1980年的73.2%和26.8%保持相对稳定。寿险包括两全保险、年金险、投连险、失能险、团体险和补充保险, 随着人口结构的变化, 老龄化快速加深, 寿险产品的结构随之发生变化, 两全保险占比逐步降低, 而年金险的比重大幅提升, 1980年两全保险和年金险占比分别为83.9%和3.7%, 而2018年占比分别为24.6%、33.3%, 年金险超越两全保险成为寿险中最主要的产品(数据来源: 德国保险业协会)。

图41: 德国人身险保费规模(百万欧元)



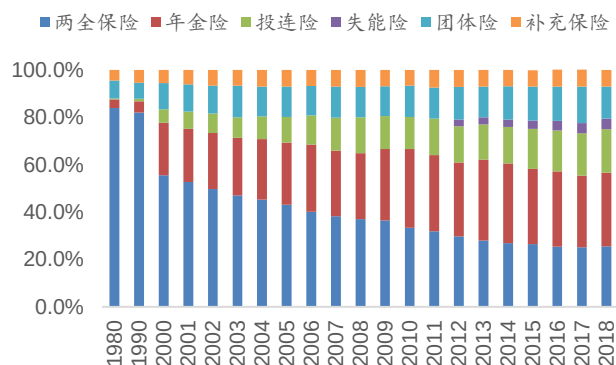
数据来源: 德国保险业协会, 广发证券发展研究中心

图42: 德国人身险产品结构



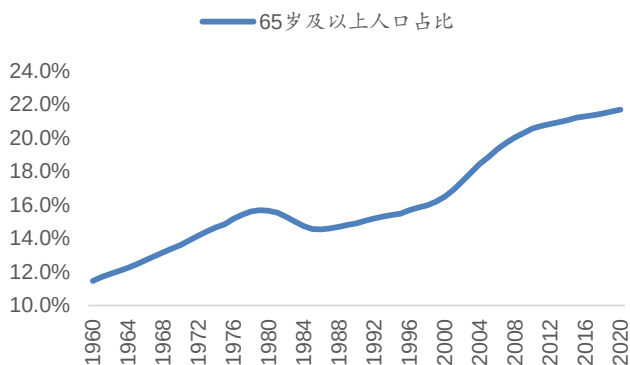
数据来源: 德国保险业协会, 广发证券发展研究中心

图43: 德国寿险行业产品结构



数据来源: 德国保险业协会, 广发证券发展研究中心

图44: 德国人口老龄化趋势

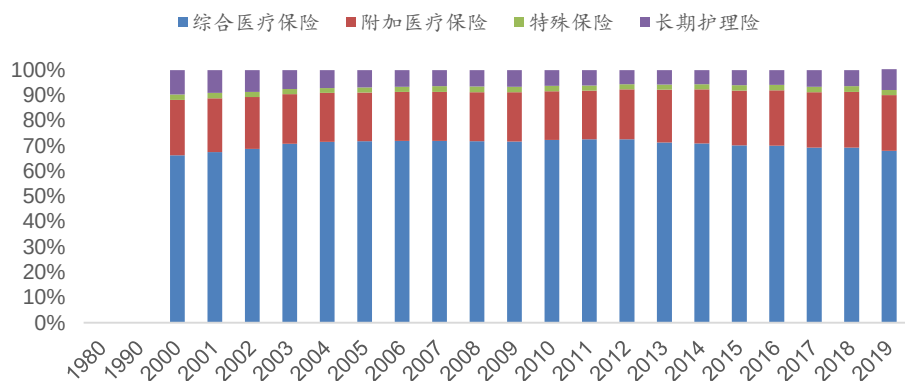


数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

从健康险的角度来看, 德国健康险主要分为综合医疗保险、附加保险、特殊保险和长期护理险, 其中附加保险包括每日津贴保险、住院津贴、综合健康保险等, 而特殊保险主要是针对国外游客购买的人身安全意外险等。健康险的结构保持相对稳定, 虽然德国是以社会医疗保险为主的国家, 保障范围较广, 每年自付比例不超过家庭收入的2%, 且社会保险中也涵盖疾病津贴, 但高收入群体可以自由选择购买社会保

险还是商业医疗保险，部分高收入群体为了使用更好的服务和覆盖牙科护理等费用，且随着人口老龄化导致的医疗成本的提升，部分社会保险的覆盖人群也为了覆盖额外的医疗费用，也会根据自身需求购买商业健康险。截至2019年，德国综合医疗保险、附加医疗保险、特殊医疗保险、长期护理险的占比分别为68.1%、22%、2%、8.2%，相较于1980年保持相对稳定（数据来源：德国保险业协会）。

图45：德国健康险产品结构



数据来源：德国保险业协会，广发证券发展研究中心

三、中外对比，我国医疗保障缺口较大，需求侧测算 我国健康险未来有望实现 10%以上复合增速

（一）基本医疗保险覆盖广，但程度低，个人负担较重

与德国、法国、日本类似，我国基本医疗制度属于社会医疗保险制度，以社会基本医疗保险为主。改革开放以来，我国大力推进医疗保险制度的建设，尤其是“新医改”以来，建成了全球最大，覆盖最广的医疗保障网，以职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险（新农村合作医疗并入居民基本医疗保险）覆盖全国13.61亿人口，覆盖全国95%以上的人口，其中职工基本医疗参保人数3.44亿人，居民基本医疗参保人数10.17亿人（2020年数据，来源于国家医保局）。

表14：我国基本医疗保险制度

	2018	2019	2020
职工基本医疗保险参保人数	31,673	32,925	34,423
城乡居民基本医疗参保人数	102,779	102,483	101,677
合计参保人数	134,452	135,408	136,100
总人口	139,538	140,005	-
参保率	96.4%	96.7%	-

数据来源：国家医保局，广发证券发展研究中心

虽然我国医疗保险覆盖率已经较高，但整体的覆盖程度还是相对较低，包括一些新型治疗方法、药品等。根据医保局的数据来看，2019年职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险中住院费用的政策内报销比例分别85.8%、68.8%，实际支付比例为

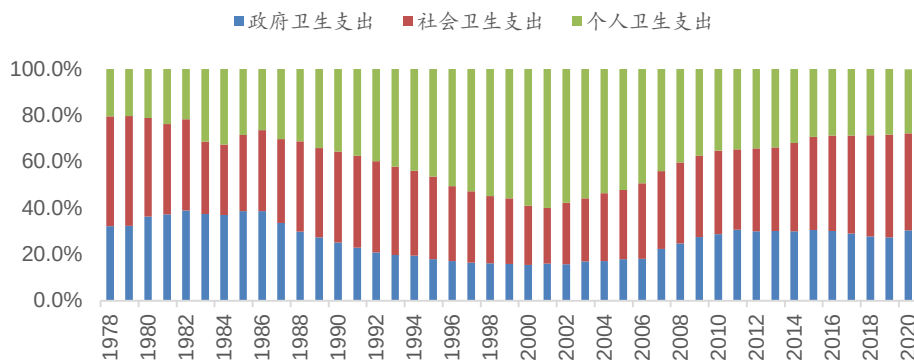
75.6%、59.7%，个人支付比例分别为24.4%、40.3%。在实际支付比例相对较低的背景下，我国卫生费用支出结构中个人卫生支出的比例相对较高，截至2020年，我国卫生费用支出中，个人支出规模为2万亿元，占总卫生费用支出比重为27.7%，较1978年的20.4%提升，较历史巅峰的60%（2001年）明显下滑，当前水平明显高于人均发达国家水平，未来仍有较大的空间来降低个人卫生费用负担水平（数据来源：国家医保局）。

表15: 2019年社会医疗保险住院费用报销比例

	职工医保			城乡居民医保		
	政策内支付比例	实际支付比例	个人负担比例	政策内支付比例	实际支付比例	个人负担比例
全国平均水平	85.80%	75.60%	24.40%	68.80%	59.70%	40.30%

数据来源：国家医保局，广发证券发展研究中心

图46: 我国卫生费用支出结构

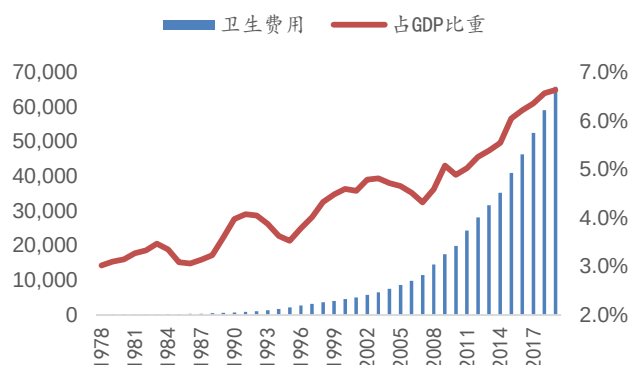


数据来源：wind，广发证券发展研究中心

（二）人口加速老龄化，医疗成本提升

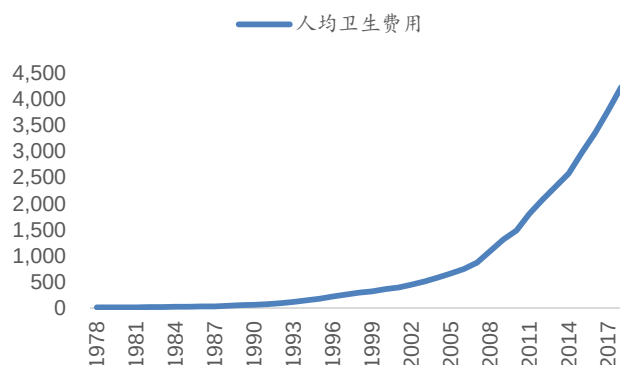
我国医疗费用成本连年增长，未来人口老龄化加速将推动医疗支出进一步增长。截至2019年我国卫生总费用6.58万亿，同比增长11.4%，改革开放以来年均复合增速16.9%，占GDP提升至6.6%。2019年次均门诊费用290.8元，同比增长6.1%，次均住院费用9848.4元，同比增6%，连年增长。“能否看的起病”始终是关乎老百姓最基本的生存问题（数据来源：卫计委）。

图47: 卫生费用和占GDP比重 (亿元)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

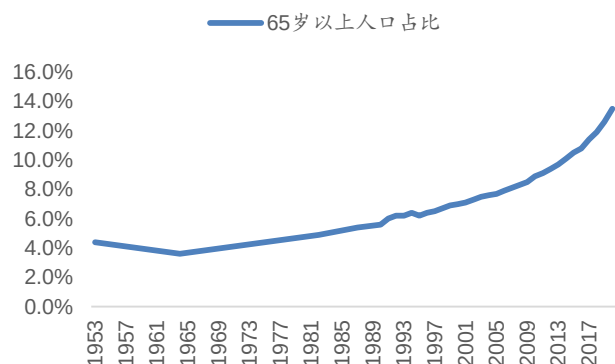
图48: 人均卫生费用陡峭式上升 (元)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

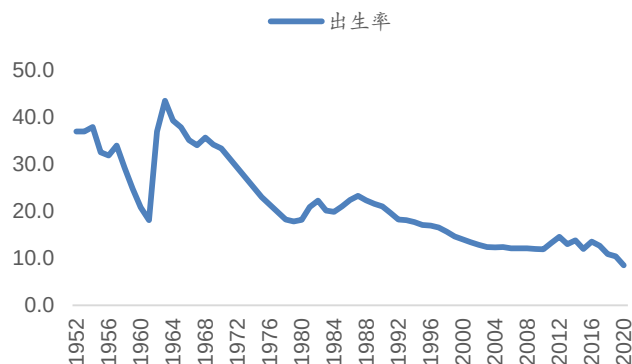
虽然我国医院主要以公立医院为主，另外通过药品集采等方式延缓医疗通胀，但随着人口老龄化程度加速，医疗费用的增长是大势所趋。截至2020年，我国65岁以上人口规模为1.91亿人，占总人口比重为13.5%，较1954年的4.4%明显提升，另外出生率首次下降至千分之个位数，仅8.52‰，随着新生人口的下降，我国人口结构的变化将持续加速，而老年人的医疗费用支出明显高于年轻人群，预计医疗费用支出占GDP的比重将会有所提升（数据来源wind）。

图49: 我国老龄化加速



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图50: 出生率首次降至历史 (‰)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

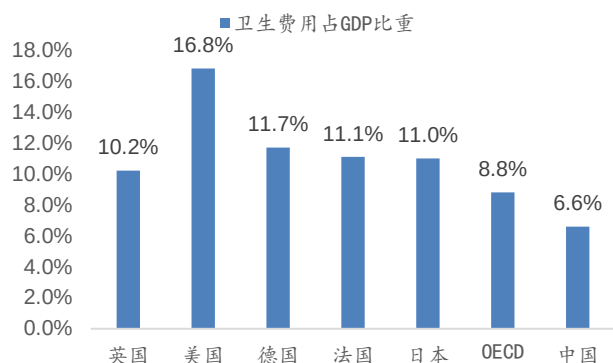
（三）测算：健康险未来10年有望实现两位数的年均复合增速

无论是筹资水平，还是筹资结构来看，我国医疗卫生费用和商业健康险的发展较大。我们从需求侧的角度来分析商业保险的发展空间，需求侧的角度也就是医疗、卫生费用等方面去分析居民对商业保险的需求。

一是从筹资水平来看，我国卫生费用支出占GDP比重为6.6%，而OECD国家平均水平为8.8%，并且发达国家的英国、美国、德国、法国、日本的卫生费用占GDP的比重分别为10.2%、16.8%、11.7%、11.1%、11%。不仅我国筹资水平略低于OECD的平均水平，另外且我国人均GDP的水平明显较低，2020年OECD国家平均GDP水平为4万美元，而我国人均GDP仅1万美元。因此无论从筹资水平来看，还是从GDP

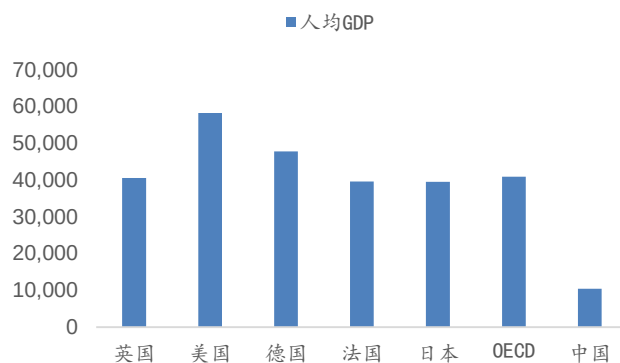
的增长情况来看，我国卫生费用都有提升的空间（数据来源OECD）。

图51：2019年卫生费用占GDP比重的横向比较



数据来源：OECD，广发证券发展研究中心

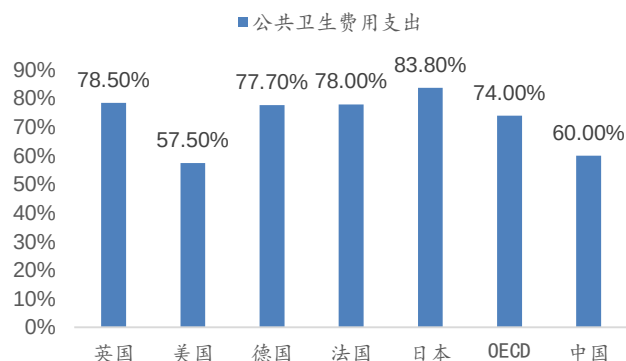
图52：2020年人均GDP水平（美元）



数据来源：OECD，世界银行，广发证券发展研究中心

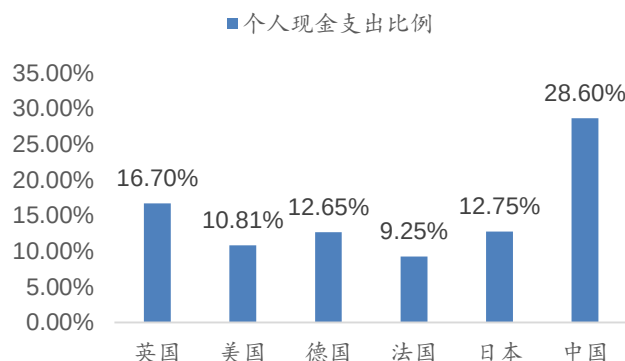
二是从筹资结构来看，筹资结构应该从两个角度来观察，卫生费用的筹资来源主要来自于公共资金（财政收入、社会医疗保险）、私人资金（个人现金支出和商业健康险的赔付）。首先从公共筹资水平来看，截至2018年我国公共筹资水平为60%，而OECD的平均水平为74%，从具体的发达国家来看，英国、美国、德国、法国、日本公共资金的比重分别为78.5%、57.5%、77.7%、78%、83.8%，借鉴海外成熟国家的水平看，我国公共筹资水平仍有提升的空间；其次是在个人现金支出方面，我国自费比例非常高，2018年占比为28.6%，高于整体OECD的水平，且明显高于成熟的英国、美国、德国、法国和日本等水平，因此自费比例有较大的下降的空间。另外便是商业保险的情况，在我国卫计委的统计下，将商业保险的赔付额计入了社会卫生支出中，据卫计委数据显示2019年我国商业健康险赔付的金额占卫生费用支出的比例仅为3.6%，仍有提升的空间（数据来源WHO和OECD）。

图53：2018年各国家卫生费用中公共筹资结构



数据来源：OECD，WHO，广发证券发展研究中心

图54：2018年各国家卫生费用中自费比例



数据来源：WHO，国家卫计委，广发证券发展研究中心

从上述需求端的分析来看，我国卫生费用的筹资水平的提升是大势所趋，且会随着经济的发展和人口的变化而有所提升，另外我国卫生费用的筹资结构同样也会有所变化，自费水平相对较高，而降低自费水平无非是提升公共筹资和商业保险两条路，而参考经合国家的水平和成熟的医疗保险体系的发达国家看，公共筹资水平和商业

健康险均有发展空间。因此我们通过一系列的假设，有望去量化测算商业健康险未来的发展空间，根据测算结果看，未来10年健康险保费有望实现年均复合增速10%-14%，达到2.1万亿-3万亿左右的水平。以下是测算的过程：

(1) 假设未来10年我国GDP的复合增速为4%，保持相对稳健的增速；

(2) 卫生费用筹资水平由7.12%提升至9%，参考当前英国、美国、德国、法国、日本平均水平为12.2%，但美国医疗支出相对较高，剔除后平均水平为11%，但10年后我国卫生费用筹资水平可能还无法达到发达国家水平，因此谨慎假设给予9%；

(3) 公共卫生支出比例假设由68%提升至70%的水平，参考当前英国、美国、德国、法国、日本平均水平为75%；

(4) 因商业健康险的发展，个人卫生支出比例下降比例分为中性假设和积极假设，其中中性假设由27.7%下降至23%，积极假设由27.7%下降至20%，参考当前英国、美国、德国、法国、日本卫生费用支出中自费比例的平均水平为12.2%，但美国医疗支出相对较高，剔除后平均水平为11%；

(5) 假设健康险赔付率由35.7%提升至45%，美国2019年商业健康险赔付率为75%，而美国因市场化机制导致医疗成本相对较高，而我国通过药品集采等方式预计将有效的控制医疗成本的快速提升；

根据以上假设，因此可以到算出来健康险赔付金额占卫生费用支出比例为7%-10%，因此可以通过GDP*卫生费用支出占比*健康险支出比例计算出健康险赔付金额，，因此可以通过赔付额/赔付率计算出健康险的保费。

表16：健康险空间测算（亿元）

	2020	2030（中性）	2030（积极）	假设备注
GDP	1,015,986	1,503,907	1,503,907	GDP 年均复合增速假设 4%
卫生费用占 GDP 比重	7.12%	9%	9%	参考发达国家水平和我国情况
个人卫生支出比例	27.70%	23%	20%	参考发达国家水平
健康险支出比例	4.04%	7%	10%	计算值
公共卫生支出比例	68.26%	70%	70%	参考发达国家水平
健康险赔付额	2,921	9,475	13,535	计算值
赔付率	35.7%	45%	45%	参考美国 2019 年商业健康险赔付率 75%
健康险规模	8,173	21,055	30,078	计算值
年均复合增速		10%	14%	计算值

数据来源：wind，广发证券发展研究中心

四、投资建议

根据人口结构的变化，我们构建了从需求侧的角度去测算健康险未来的发展空间，并通过研究世界上典型的医疗保险制度，无论是国家卫生服务体系，还是商业医疗保险体制，亦或者是社会医疗保险制度，都有一个相通点，便是通过不断的完善医疗保险制度来提升国民健康素质的背景下降低个人现金支出比例。从数据可以显示，英国（国家卫生服务体系的典型国家）、美国（商业医疗保险体系的典型国家）、德国、法国和日本（社会医疗保险的典型国家）的卫生费用支出的比例在10%-13%

之间。反观当前我国卫生费用支出中自费比例相对较高，而公共筹资水平已经相对较高，而我们认为在人口结构变化导致的医疗费用提升的背景下，商业健康险的发展有望降低我国居民医疗费用负担，因此我们认为未来商业健康险仍是一片蓝海，发展空间较大，而当前我国保险公司的估值已处在历史较低的水平，反应市场对于保险行业负债端的悲观假设，中长期推荐：中国平安（A/H）、友邦保险（H）、中国太保（A/H）。

五、风险提示

利率超预期下行当前10年期国债收益率处于2.7%左右的水平，后续国内经济若复苏程度低于预期，并且考虑到外部疫情的蔓延和国际形势的紧张，导致长期债券的收益率超预期下行对保险公司的投资收益率和内含价值造成影响。

新单销售不达预期保险产品属于偏向可选消费类型，疫情导致居民收入下降及未来现金流预期趋于谨慎，因此影响保险新单新产品的销售，导致新业务价值增速处于低位。

广发非银金融行业研究小组

陈 福：首席分析师，经济学硕士，2017 年 3 月进入广发证券研究发展中心。

陈 卉：资深分析师，英国布里斯托大学（University of Bristol）金融投资专业硕士，2017 年进入广发证券发展研究中心。

陈 韵 杨：资深分析师，香港中文大学经济学硕士，中山大学学士，2017 年进入广发证券发展研究中心。

刘 洪：资深分析师，中南财经政法大学投资学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

陈 思 宇：研究助理，西安交通大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。